

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO

Paloma Pérez Del Pozo, Goyo Laguna, Julio Tito Camino Acha. Neiser Eduardo Palmer Camino.

INTRODUCCIÓN.

Engloba 3 patologías (disección aórtica, hematoma intramural, úlcera penetrante) diferenciadas que comparten una fisiopatología, un diagnóstico y tratamiento comunes. Constituyen procesos de la pared aórtica que afectan a la capa media y condicionan un riesgo potencial de complicaciones y rupturas. La incidencia es de 30 casos por millón de habitantes. Mas frecuente en hombres (70%) con una edad media de 60 años. Mas frecuente es la disección aórtica (80%), el hematoma intramural (15%) y por ultimo la úlcera penetrante (5%). Tiene una alta mortalidad (el 40 % no llegan al hospital) que aumenta con cada hora de retraso en el tratamiento quirúrgico cuando está indicado.

Dentro de este síndrome se engloban:

1º Disección aórtica

Constituye el 80 % y es responsable del 1% de las muertes súbitas. Es una urgencia médico-quirúrgica. Desgarro de la íntima y capas internas de la media resultando en una separación de sus capas, pudiendo afectar a la aorta en sus diferentes niveles (torácica, abdominal) así como a sus ramas.

La edad media de aparición según localización es de 55 años en la ascendentes y 63 años en la descendente, siendo su incidencia más frecuente en el género masculino.

Existen varias clasificaciones:

Clasificación según el tiempo de evolución.

- **Aguda:** síntomas de menos de 14 días de evolución.
- **Crónica:** síntomas superiores a 14 días.

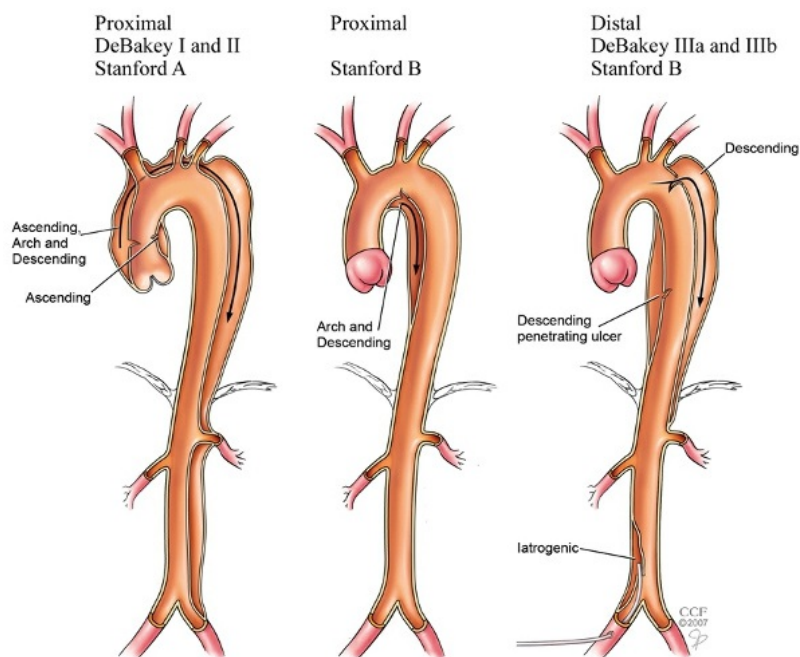
La clasificación anatómica según afecte o no a la aorta ascendente (próximo al tronco braquiocefálico) o independientemente del lugar donde se origine la disección. Esta clasificación determinará el tratamiento pertinente.

De Barckey

- **Tipo I:** Se origina en aorta ascendente y se propaga distalmente, al menos hasta el arco, y típicamente a la aorta descendente (distal a la subclavia izquierda). Tratamiento quirúrgico recomendado.
- **Tipo II:** Se origina en aorta descendente. Tratamiento quirúrgico recomendado.
- **Tipo III:** Se origina en aorta descendente y se propaga habitualmente de forma distal. Tratamiento quirúrgico usualmente no recomendado. Pero puede también progresar de forma proximal hacia aorta ascendente (disección retrógrada).
 - **Tipo IIIa:** limitada a aorta descendente torácica.
 - **Tipo IIIb:** Extendida a aorta abdominal.

De Stanford

- **Tipo A proximal:** 68%. Aorta ascendente independientemente de extensión y localización de desgarro. Tratamiento quirúrgico
- **Tipo B distal:** 32%. No se afecta la ascendente. Tratamiento inicial no quirúrgico.



2º Hematoma intramural

Constituyen el 15%: Se encuentra confinado en la pared aórtica. Se propone que es debido a una hemorragia de la vasa-vasorum de la capa media o por desgarros intímiales microscópicos. La mayoría son un DA. Típicos de aorta descendente y en pacientes mayores. El dolor es el síntoma principal, los signos de déficit son menos frecuentes que en la DA. El diagnóstico por imagen se basa en la presencia de un trombo fresco en la pared aórtica sin flap ni falsa luz. El tratamiento con betabloqueantes en descendente mejora la supervivencia.

3º Úlcera penetrante aórtica

Constituye el 5%: Lesión arterioesclerótica con ulceración que penetra en la lámina elástica interna y permite la formación de hematomas en la capa media de la pared. Puede evolucionar a un DA o HIM o rotura del vaso. 90% aorta descendente. Suele afectar a pacientes de >65 años con HTA y arterioesclerosis difusa que se presenta con dolor torácico o de espalda sin signos de IAo ni malperfusión.

FACTORES DE RIESGO

Todos aquellos que favorecen una degeneración en la capa media y estrés sobre la pared aórtica.

- Aumento de la presión en la pared aórtica: HTA (la más frecuente 75%), traumatismo directo, Valsalva. Sobre todo B.
- Anomalías en la media: Coartación de aorta, Enfermedades del tejido conectivo, Aorta bicúspide, síndrome familiar de aneurismas y disección aórtica torácica, Enfermedad poliquística renal autosómica dominante, Síndrome de Noonan. Sobre todo A.
- Vasculitis inflamatorias: Arteritis de células gigantes, Takayasu, aortitis, infecciones, Síndrome de Beçhet, Espondilitis Anquilosante. Sobre todo A.
- Otras: embarazo 3º trimestre, arteria subclavia aberrante, hiperlipidemia, tratamiento crónico con esteroides o inmunosupresión, aneurisma cerebral, Intervenciones previas con manipulación de la aorta torácica (cirugía cardíaca o intervencionismo percutáneo que pueden

lesionar la íntima).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El diagnóstico se basa en la exploración física exhaustiva y se confirma con técnicas de imagen cada vez más eficientes. Dentro de los datos clínicos se encuentra:

El dolor de inicio brusco e intenso tipo lancinante de localización centro torácico si afecta la aorta ascendente y de localización interescapular si afecta la aorta descendente. El dolor puede ser migratorio (25%), se puede irradiar a las mandíbulas, el epigastrio, la región lumbar o las extremidades inferiores, son similares en las tres formas de SAA, dada la alta mortalidad es obligado mantener un alto índice de sospecha.

- Dolor: 95%. Es atípico, torácico-retroesternal agudo migratorio con posible irradiación a zonas como espalda, cuello, mandíbula, abdomen. Es descrito como “desgarro”, “puñalada”. Es espontáneo o provocado por esfuerzo. Puede ceder o desaparecer originando una falsa sensación de mejoría.
- Déficit de perfusión: como déficit de pulso o déficits locales neurológicos.
- Isquemia de los órganos: complicaciones gastrointestinales.
- Síncope (hipotensión, shock) y/o
- Insuficiencia aórtica de novo en auscultación y dolor.
- Derrames pleurales.

DIAGNÓSTICO

Tras la sospecha clínica, se debe:

- Realizar anamnesis dirigida a buscar factores de riesgo asociados a SAA.
- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, proteína C reactiva (PCR), Procalcitonina. CK, CKmb, Troponina US.
- Coagulación con Dímero D.
- Gasometria venosa.
- Rx Tórax AP y Lateral: en el 85% de DA o AA se observa ensanchamiento mediastínico, derrame pleural, contornos anómalos cardíacos o aórticos. La Rx normal no descarta el síndrome.
- ECG: signos de hipertrofia ventricular (más frecuente), isquemia, necrosis. El 38% son normales.
- El TAC con contraste IV, la ecocardiografía transesofágica (ETE) y la RMN son de alta fiabilidad y con un 100% de sensibilidad en las tres técnicas, siendo ligeramente superior en especificidad el TAC. La elección de uno u otra se individualiza: **Paciente inestable hemodinámicamente:** ETE (se evita mover al paciente).

El diagnóstico de DA no puede excluirse con una sola prueba, ya que si se sigue teniendo una alta sospecha, se debe realizar una segunda prueba diagnóstica.

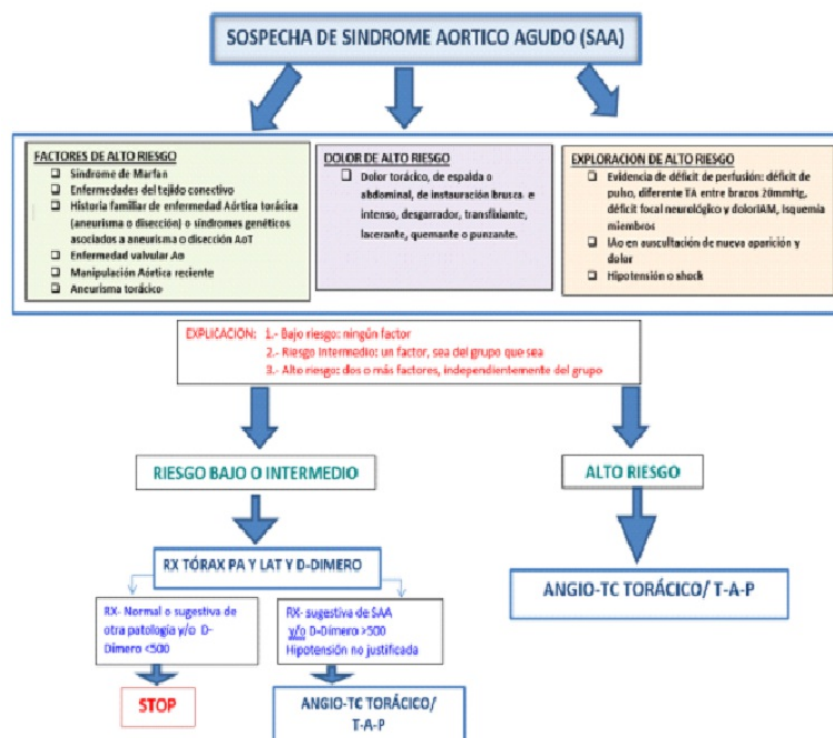
En caso de no encontrar diagnóstico alternativo y en presencia de Shock o ensanchamiento mediastínico en Rx de tórax hay que valorar la realización de TAC, ETE o RMN.

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO.

Hay hallazgos de alto riesgo en la valoración inicial que incrementan la probabilidad de SAA. La

combinación >2 requieren el uso de técnicas específicas de imagen para confirmar el diagnóstico y tipo anatómico con consulta inmediata con Cirugía Cardíaca para su valoración:

- Condiciones de alto riesgo: enfermedad del tejido conectivo, historia familiar de enfermedad aórtica, valvulopatía aórtica, manipulación aórtica reciente o aneurisma conocido.
- Dolor de alto riesgo: abdominal o torácico, de inicio abrupto y de intensidad severa, con calidad desgarrante o tipo puñalada (debe cumplir las 2).
- Hallazgos exploratorios de alto riesgo: déficits de perfusión, soplo de LAo nuevo, hipotensión o shock



TRATAMIENTO

MANEJO INICIAL DA

Calmar el dolor y evitar la propagación controlando el estrés sobre la pared aórtica.

- Dolor: Perfusión de cloruro morfíco o fentanilo iv. Evitar el Propofol (efecto hemodinámico).
- Ansiedad: Orfidal o Tranxilium.
- Agitación-confusión: Descartar afectación neurológica. Perfusión de Haloperidol 1 mg/h. Midazolam 1mg en 10 segundos y 5 mg en 30 segundos.
- HTA: Betabloqueantes IV. Atenolol: dosis de carga 2.5mg posteriormente de mantenimiento 0.15mg/kg/día, propranolol, o alfa-betabloqueantes (Labetanol: dosis crecientes entre 0.5-4mg/día).

Si contraindicación: Diltiazem o Verapamilo iv.

- Hipotensión: expansores de volumen plasmático.

Vasopresores (aumentan riesgo de progresión)

El objetivo es evitar la progresión de la disección.

Sin hipertensión, ni dolor: Atenolol 25 mg/12h

Hipertensión, mantener TA < 120 de sistólica y < 80 diastólica con buena perfusión periférica y diuresis conservada.

En pacientes hipertensos labetalol iv 1 mg/min.

Si contraindicación para el uso de beta bloqueantes administrar Diltiazem 25mg iv en bolo y luego en perfusión continua.

Si alteración renal IECA y diuréticos solo si se confirma normovolemia.

MANEJO DE HIM Y PAU:

Prevenir la rotura de la aorta o su progresión a una A clásica. La elección de una técnica quirúrgica o endovascular se individualiza.

MANEJO DEFINITIVO DA

Disección tipo B: tratamiento médico es superior al quirúrgico-endovascular. Se reservan en casos de complicaciones (expansión aneurisma, progresión DA, signos de malperfusión, HTA incontrolable).

Disección tipo A: Emergencia quirúrgica. Resección de la porción proximal de la aorta y toda la aorta aneurismática o resuspensión de los velos valvulares aórticos nativos cuando sea posible.

Tratamiento quirúrgico- endovascular:

Disección tipo B

Se debe individualizar por un equipo multidisciplinar que establecerán si abierto o endovascular.

- Dolor intenso (si buen control de la TA) y refractario a tratamiento medico o reaparición de dolor torácico-lumbar a pesar de tratamiento medico intensivo.
- Sangrado importante en cavidad pleural, hemomediastino, hematoma periaortico o retroperitoneo con evidencia de sangrado por técnica de imagen.
- Compromiso circulatorio mantenido en troncos supraaortic, arterias renales (oligoanuria descartada hipovolemia), o de compromiso grave del flujo o alguna de las EEII.
- Crecimiento significativo del diámetro de la aorta por técnicas de imagen.
- Sospecha de erosión o compresión de alguna estructura que represente un peligro para la vida (síndrome de vena cava superior, hemoptisis no justificada por otras causas, compresión de un bronquio ppal o de segundo orden, cuadro abdominal sospechoso de ser secundario a una disección.

Tratamiento médico del saa crónico:

Estabilidad clínica y con paso de al menos de dos semanas desde el episodio agudo. Es fundamental un correcto control de la TA y de los factores de riesgo CV. Evitar esfuerzos físicos intensos sobre todo isométricos y competitivos.

EL fármaco de elección es inotropo negativo , bb o alfab y si contraindicación o intolerancia diltiazem o verapamilo

BIBLIOGRAFÍA.

- Erbel R, Aboyans V, Boileu C et al. Guía ESC 2014 sobre el diagnóstico y tratamiento de la patología de la aorta. Documento sobre las patologías aórticas crónicas de las aortas torácica y abdominal del adulto.
- Evangelista Masip A: Avances en el síndrome aórtico agudo. Rev.Esp.Card; 60 (4): 428-439; Abril 2007.
- Bustamante-Munguira J, Juez M. Acute aortic síndrome. Síndrome aórtico agudo. Rev. Cir. Cardiovascular; 23(1): 38-44; Enero-febrero 2016.
- Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.

VIDEO

<https://youtu.be/dAoENOfrrfE>